

PROPUESTA DE MENSAJE PRESIDENCIAL

**PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.961,
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE,
PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE
DEL PERSONAL INVALIDADO EN ACTOS DEL SERVICIO**

*Fundamentos constitucionales y legales, jurisprudencia administrativa y judicial,
y articulado propuesto*

Autor

General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

Abogado, Magíster en Ciencia Política (mención Gobierno), Universidad de Chile

Miembro de Número de CENEOP

Past-President Cuerpo de Generales

Santiago de Chile, septiembre de 2026

(Actualiza y reemplaza la versión anterior, sin fecha, de este proyecto)

NOTA PRELIMINAR

El presente documento contiene una propuesta técnica de Mensaje Presidencial. Se presenta en esta forma porque las materias que aborda —la extensión de un beneficio de salud de cargo fiscal y su incidencia en el régimen de seguridad social del personal de Carabineros de Chile— son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 65, incisos tercero y cuarto N° 6°, de la Constitución Política de la República. Su finalidad es servir de base para que el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, patrocine la iniciativa ante el Congreso Nacional.

Las referencias normativas corresponden al texto vigente de la Ley N° 18.961 consultado en septiembre de 2026. Las referencias jurisprudenciales se individualizan en el capítulo IV; aquellas cuyo número de rol no se consigna deben ser completadas con la fuente oficial antes de la presentación formal de la iniciativa.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.961, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE, PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE DEL PERSONAL INVALIDADO EN ACTOS DEL SERVICIO

Santiago, ____ de _____ de 20__.

MENSAJE N° ____ / ____

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto modificar la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, con el fin de asegurar que el personal que resulte invalidado a consecuencia de un accidente en acto del servicio conserve, después de su retiro, el derecho a que sea de cargo fiscal la atención de salud que requieran las secuelas de dicho accidente.

I. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

1. El problema que se busca resolver

El artículo 34 de la Ley N° 18.961 dispone que el personal que se accidentare en actos del servicio o se enfermase a consecuencia de sus funciones tendrá derecho a que sean de cargo fiscal todos los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y demás similares relativos a su tratamiento clínico, **«hasta ser dado de alta definitiva o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones»**.

La norma produce un efecto paradójico. Cuando la lesión es leve o recuperable, el funcionario recibe atención íntegra de cargo fiscal hasta su alta. Pero cuando la lesión es tan grave que lo inutiliza para el servicio, la cobertura fiscal se extingue precisamente en el momento en que es declarado imposibilitado, esto es, cuando las secuelas son mayores y más duraderas. Desde entonces, el tratamiento de esas secuelas —rehabilitación, medicamentos de uso continuo, prótesis, órtesis, intervenciones futuras, apoyo psicológico— queda entregado al régimen ordinario de medicina curativa de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), financiado con las cotizaciones del propio afectado y sujeto a copagos, topes y a las limitaciones del reglamento respectivo.

En otras palabras, bajo la legislación vigente, **a mayor sacrificio en el servicio, menor protección de cargo del Estado**. El presente proyecto corrige esa inconsistencia.

2. El contexto

Carabineros de Chile tiene por misión constitucional dar eficacia al derecho y garantizar el orden público y la seguridad pública interior. El cumplimiento de esa misión expone a su personal, de manera cotidiana, a agresiones y riesgos que no enfrenta ningún otro servidor civil del Estado. El

propio legislador ha reconocido esa realidad al reforzar la protección penal de las policías mediante la Ley N° 21.560. Esa protección, sin embargo, es sancionatoria y no reparatoria: castiga al agresor, pero no asegura el tratamiento de por vida de quien quedó invalidado por la agresión.

El costo de las lesiones invalidantes no es solo individual. Constituye un costo moral para la institución, que ve a sus hombres y mujeres enfrentar solos las secuelas del deber cumplido, y un costo para el Estado y la sociedad, que dependen de la disposición del personal a exponerse al riesgo. Un Estado que exige ese riesgo debe hacerse cargo de sus consecuencias.

Finalmente, cabe consignar que la Ley N° 21.730 creó el Ministerio de Seguridad Pública, del cual depende hoy Carabineros de Chile. Es a través de esa cartera que corresponde canalizar la presente iniciativa y su financiamiento.

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1°). La Constitución asegura a todas las personas:

«El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.»

La salud es el bien jurídico que da contenido material a esa garantía. Cuando la lesión a la integridad se produce en cumplimiento de un mandato del propio Estado, el deber estatal de protección se intensifica.

Derecho a la protección de la salud (artículo 19 N° 9°). La Carta Fundamental dispone:

«El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.»

La rehabilitación y la recuperación de quien se invalidó en acto del servicio son, precisamente, las «acciones de salud» cuya ejecución el Estado debe garantizar de modo preferente.

Igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2°). Como se expone en el capítulo III, un trabajador del sector privado accidentado en su trabajo recibe prestaciones médicas gratuitas mientras subsistan las secuelas de su accidente, mientras que un carabinero invalidado en acto del servicio pierde la cobertura fiscal al ser declarado imposibilitado. Esa diferencia carece de una justificación objetiva y razonable, y opera además en perjuicio de quien asume el mayor riesgo.

Derecho a la seguridad social (artículo 19 N° 18°). La acción del Estado debe estar dirigida a garantizar el acceso a prestaciones básicas uniformes. La atención de las secuelas de un accidente en acto del servicio es una prestación de seguridad social de naturaleza reparatoria, que el Estado debe asegurar.

Estatuto constitucional de Carabineros (artículos 101 y 105). Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior. El artículo 105 reserva a una ley orgánica constitucional las normas básicas sobre carrera profesional y previsión del personal, razón por la cual la presente modificación debe introducirse en la Ley N° 18.961.

III. MARCO LEGAL VIGENTE Y ANÁLISIS COMPARADO

1. Ley N° 18.961, *Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile*

- **Artículo 33:** en caso de enfermedad o accidente ocurrido en el servicio, el personal goza de su sueldo íntegro hasta la recuperación de su salud.
- **Artículo 34:** gastos médicos de cargo fiscal por accidente en acto del servicio o enfermedad a consecuencia de las funciones, hasta el alta definitiva o la declaración de imposibilidad para reasumir funciones. Una resolución fundada, dictada en un plazo no superior a treinta días, califica el accidente para efectos de la imputación del gasto.
- **Artículo 63:** define el accidente en acto del servicio, incluyendo el ocurrido con motivo de una intervención policial aun estando franco, el de trayecto y el ocurrido a bordo de naves o aeronaves policiales.
- **Artículo 64:** entrega exclusivamente a la Comisión Médica Central de Carabineros el examen del personal para establecer su capacidad física o la afección que le impide continuar en el servicio; en caso de invalidez, el General Director resuelve en definitiva su clasificación, previo informe técnico de dicha Comisión.
- **Artículo 65:** establece las pensiones de invalidez de primera, segunda y tercera clase para el personal inutilizado a consecuencia de un accidente en acto del servicio, y asimila a la segunda clase al personal afectado por enfermedad profesional o invalidante de carácter permanente.
- **Artículo 66:** regula el reajuste automático de las pensiones de retiro y sus límites.
- **Artículo 67:** define la enfermedad profesional y la enfermedad invalidante de carácter permanente.

Como se aprecia, la ley regula con detalle la **pensión** del inválido en acto del servicio, pero guarda silencio sobre su **atención de salud** una vez retirado. Ese vacío es el que este proyecto viene a llenar.

2. Régimen de salud de DIPRECA

El personal en retiro accede a las prestaciones de medicina curativa de DIPRECA conforme al artículo 9° del Decreto Ley N° 844, de 1975, y al Decreto N° 509, de 1989, del Ministerio de Defensa Nacional (publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 1990). Se trata de un régimen financiado con cotizaciones de los propios imponentes y sujeto, en cuanto a su otorgamiento, a las limitaciones

y modalidades que fije el reglamento. No es un régimen reparatorio: trata la secuela de un accidente en acto del servicio del mismo modo que cualquier enfermedad común.

3. Comparación con el régimen general de accidentes del trabajo

La Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dispone en su artículo 29 que la víctima de un accidente del trabajo tiene derecho a prestaciones médicas que se otorgan gratuitamente **«hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente»**. El trabajador del sector privado, por tanto, conserva la cobertura mientras subsistan las secuelas, aunque haya dejado de trabajar.

El personal de Carabineros, excluido de la Ley N° 16.744 por contar con un régimen especial, se encuentra paradójicamente en una situación menos favorable en este punto específico: su cobertura termina con la declaración de imposibilidad. El régimen especial, concebido para proteger más a quienes asumen un riesgo mayor, termina protegiéndolos menos.

4. Comparación con las Fuerzas Armadas

El artículo 75 de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, contempla una regla análoga al artículo 34 de la Ley N° 18.961, que hace de cargo fiscal los gastos de atención médica del personal accidentado en actos del servicio, previa investigación sumaria administrativa. La reforma que aquí se propone puede, por tanto, servir de modelo para una futura homologación en el ámbito de la Defensa Nacional.

IV. JURISPRUDENCIA

A. Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República

Dictamen N° 21.116, de 2013. Al pronunciarse sobre el régimen de accidentes en actos del servicio de las Fuerzas Armadas, la Contraloría precisó que el personal accidentado tiene derecho, previa investigación sumaria administrativa, a que sean de cargo fiscal los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y los demás medios terapéuticos relativos al tratamiento prescrito, incluidos los gastos de transporte y los de controles y exámenes posteriores; y que la determinación de la capacidad del personal y de la clase de inutilidad corresponde exclusivamente al órgano médico institucional. **Relevancia:** confirma que el sistema reconoce la naturaleza fiscal y reparatoria de estos gastos; el proyecto solo extiende en el tiempo esa misma lógica.

Dictamen N° 59.651, de 2016. La Contraloría resolvió que un accidente al que contribuyó la conducta del servidor, con infracción de sus deberes funcionarios, no puede ser calificado como acto del servicio. **Relevancia:** demuestra que el ordenamiento ya cuenta con un filtro que impide extender beneficios a lesiones originadas en conductas indebidas. El beneficio que se propone queda circunscrito, por su propia definición, a quienes se invalidaron cumpliendo correctamente su deber.

Dictamen N° 7.211, de 2020. Referido a un exfuncionario de la Policía de Investigaciones, da cuenta de que la institución, tras el sumario que calificó el accidente como ocurrido en acto del servicio, dispuso que los gastos médicos fueran cubiertos por ella, y de que el afectado, por estar afiliado al sistema del Decreto Ley N° 3.500, no podía impetrar beneficios previsionales de DIPRECA. **Relevancia:** ilustra la fragmentación del sistema: la cobertura de salud del accidentado depende hoy de su régimen previsional y del momento en que se encuentra su proceso, y no de la causa de su lesión. El proyecto ancla el beneficio en la causa —el acto del servicio— y no en el régimen de afiliación.

Dictamen N° 930, de 2021. Aplicó el artículo 100 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, que considera eliminado por invalidez de segunda clase al personal acogido a medicina preventiva que fallece en servicio activo antes de ser declarado irrecuperable. **Relevancia:** es un precedente de técnica legislativa protectora: el legislador ya ha dictado normas especiales para evitar que el momento administrativo de la declaración de invalidez perjudique al afectado o a su familia.

Dictamen N° E455118, de 2024. Recordó que los beneficios médicos que otorga DIPRECA están sujetos, en cuanto a su otorgamiento, a las limitaciones y modalidades del reglamento contenido en el Decreto N° 509, de 1989. **Relevancia:** confirma que el régimen ordinario de DIPRECA es de rango reglamentario y limitado, por lo que la atención permanente del inválido en acto del servicio requiere una norma de rango legal que la asegure.

B. Jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia

Corte Suprema, Rol N° 29.115-2025, de 29 de julio de 2025 (Tercera Sala). Confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección deducido contra la Comisión Médica Central de Carabineros, dejó sin efecto las resoluciones que dispusieron el retiro de una funcionaria por imposibilidad física y ordenó practicar una nueva evaluación médica completa, por carecer la decisión de la Comisión de un fundamento fáctico y científico suficiente. **Relevancia:** los pronunciamientos de la Comisión Médica Central deben ser fundados. El proyecto exige, en coherencia, que dicha Comisión se pronuncie expresa y fundadamente sobre el tratamiento que requerirá el inválido tras su retiro.

Corte Suprema, 2023 (reseñada en Diario Constitucional, 20 de marzo de 2023). Declaró que el recurso de protección no es la vía idónea para examinar si un oficial de Carabineros goza o no de salud apta para el servicio, por existir recursos administrativos y la posibilidad de un juicio de lato conocimiento. **Relevancia:** la vía cautelar no suple la falta de una regla legal clara. Hoy, el inválido que ve interrumpida su atención carece de un derecho legal expreso que invocar; el proyecto se lo otorga.

Corte Suprema, Rol N° 41.915-2025 (sentencia de marzo de 2026), que revocó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 2.091-2025. En un caso relativo al Ejército de Chile, rechazó el recurso de protección deducido contra la resolución que, en una investigación sumaria

administrativa, concluyó que el fallecimiento de un funcionario no ocurrió en acto del servicio, declarando que la acción cautelar no es la vía para revisar el mérito de un procedimiento administrativo reglado. **Relevancia:** aunque recaído en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el criterio es plenamente aplicable al régimen de Carabineros: la calificación de acto del servicio se radica en el procedimiento administrativo. Por ello el proyecto vincula el beneficio a esa calificación ya existente, sin crear procedimientos paralelos.

Corte Suprema, Rol N° 54.443-2025, confirmatoria de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 2.691-2025 (reseñada en Diario Constitucional, 28 de marzo de 2026). Rechazó el recurso de protección de un funcionario que impugnaba la declaración de imposibilidad física; respaldó las decisiones técnicas de la Comisión Médica Central de Carabineros y delimitó el control judicial sobre la calificación de aptitud para el servicio. **Relevancia:** los tribunales reconocen a la Comisión Médica Central como el órgano técnico competente. El proyecto aprovecha esa competencia y le encarga determinar la necesidad y duración del tratamiento posterior al retiro.

Tribunal Constitucional, Rol N° 17.088-25-INA (requerimiento de inaplicabilidad ingresado en noviembre de 2025, reseñado en Diario Constitucional, 13 de noviembre de 2025). Un exoficial impugnó el inciso primero del artículo 64 de la Ley N° 18.961, que entrega exclusivamente a la Comisión Médica Central de Carabineros el examen de la capacidad física del personal. **Relevancia:** la competencia exclusiva de dicha Comisión se encuentra cuestionada en sede constitucional. El proyecto no altera esa competencia, pero exige que sus informes se pronuncien fundadamente sobre el tratamiento posterior al retiro y permite su revisión cuando sobrevengan nuevos antecedentes médicos, lo que refuerza las garantías del afectado.

C. Derecho comparado

Corte Constitucional de Colombia, sentencias T-063 de 2007 y T-848 de 2010. La Corte colombiana ha sostenido que el retiro del uniformado no puede ser obstáculo para la continuidad del tratamiento médico que venía recibiendo por lesiones adquiridas en el servicio, el que debe mantenerse hasta la recuperación definitiva del paciente o hasta que se garantice su continuidad por otros actores del sistema de seguridad social. **Relevancia:** en un ordenamiento con fuerza pública comparable, la solución que aquí se propone ha sido reconocida como exigencia de los derechos a la salud y a la vida digna.

V. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto introduce tres modificaciones a la Ley N° 18.961, articuladas en torno a una idea central: **el derecho a la atención de cargo fiscal por un accidente en acto del servicio no se extingue con el retiro cuando ese accidente causó la invalidez.**

- **Artículo 34 (núcleo de la reforma):** se agrega un nuevo inciso que extiende, después del retiro, la cobertura de cargo fiscal de las secuelas del accidente en acto del servicio que causó

la invalidez —incluidos los gastos de transporte y de controles médicos posteriores—, mientras éstas requieran tratamiento. El beneficio no alcanza a las enfermedades profesionales ni a las invalidantes de carácter permanente, que siguen rigiéndose por las normas generales, lo que acota el universo de beneficiarios y el costo fiscal. El gasto no se imputa a los fondos de medicina curativa de DIPRECA, evitando trasladar al conjunto de los imponentes un costo que corresponde al Estado.

- **Artículo 64:** se encarga a la Comisión Médica Central pronunciarse, en su informe técnico, sobre el tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos que el afectado requerirá después de su retiro, y si serán temporales o permanentes. El General Director resuelve fundadamente en el mismo acto en que clasifica la invalidez, y la resolución puede revisarse si sobrevienen nuevos antecedentes médicos.
- **Artículo 65:** la resolución que concede una pensión de invalidez de primera, segunda o tercera clase originada en acto del servicio debe dejar constancia del derecho a la atención permanente, de modo que el beneficio quede documentado junto a la pensión.

Las disposiciones transitorias permiten al personal ya pensionado por invalidez en acto del servicio solicitar el pronunciamiento de la Comisión Médica Central, sin efecto retroactivo sobre gastos pasados; aplican la nueva regla a los procesos de clasificación en curso; y establecen el financiamiento y el plazo para dictar el reglamento.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile:

- 1) **En el artículo 34:** Intercálase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

«Con todo, el personal que resulte inutilizado a consecuencia de un accidente en acto del servicio, en los términos del artículo 63, conservará después de su retiro los derechos establecidos en el inciso anterior y en el inciso cuarto respecto de las secuelas derivadas de dicho accidente, mientras éstas requieran tratamiento, conforme a lo resuelto de acuerdo con el inciso tercero del artículo 64. Estos gastos serán de cargo fiscal y no podrán imputarse a los fondos de medicina curativa de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Lo dispuesto en este inciso no se aplicará a las enfermedades profesionales ni a las enfermedades invalidantes de carácter permanente, las que se regirán por las normas generales.»

- 2) **En el artículo 64:** Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

«Tratándose de invalidez originada en un accidente en acto del servicio, el informe técnico de la Comisión Médica Central deberá pronunciarse fundadamente sobre el

tratamiento, rehabilitación, medicamentos, insumos, prótesis u órtesis que el afectado requerirá con posterioridad a su retiro, indicando si tendrán carácter temporal o permanente. El General Director resolverá sobre esta materia en el mismo acto en que clasifique la invalidez. Dicha resolución podrá ser revisada, de oficio o a petición del interesado, cuando sobrevengan antecedentes médicos que lo justifiquen.»

3) En el artículo 65: Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

«La resolución que conceda una pensión de invalidez de primera, segunda o tercera clase originada en un accidente en acto del servicio dejará constancia del derecho del pensionado a la atención de salud establecida en el inciso segundo del artículo 34 y de su carácter temporal o permanente, conforme a lo resuelto de acuerdo con el inciso tercero del artículo 64.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El personal que a la fecha de publicación de esta ley se encuentre en goce de una pensión de invalidez originada en un accidente en acto del servicio podrá solicitar, dentro del plazo de dos años contado desde dicha publicación, que la Comisión Médica Central emita el pronunciamiento a que se refiere el inciso tercero del artículo 64 de la Ley N° 18.961. El derecho que se reconozca regirá desde la fecha de la resolución respectiva, sin efecto retroactivo respecto de gastos anteriores.

El personal cuya invalidez originada en un accidente en acto del servicio se encuentre en proceso de clasificación a la fecha de publicación de esta ley quedará sujeto a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 64 de la Ley N° 18.961, debiendo la Comisión Médica Central incluir el pronunciamiento respectivo en su informe técnico. Si dicho informe ya hubiere sido evacuado, el interesado podrá formular la solicitud a que se refiere el inciso anterior dentro del mismo plazo.

Artículo segundo.- Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Hacienda, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley, regulará el procedimiento, la forma de otorgamiento de las prestaciones y los mecanismos de control del beneficio.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, partida presupuestaria de Carabineros de Chile y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Dios guarde a V.E.,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MINISTRO DE HACIENDA

VI. VÍA DE TRAMITACIÓN Y RECOMENDACIONES

Iniciativa exclusiva. Por irrogar gasto fiscal e incidir en normas de seguridad social, el proyecto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República (artículo 65, incisos tercero y cuarto N° 6°, de la Constitución). Una moción parlamentaria con este contenido se expondría a ser declarada inadmisibile.

Quórum. Por modificar una ley orgánica constitucional (artículos 101 y 105 de la Constitución), requiere la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, conforme al artículo 66 de la Constitución en su texto fijado por la Ley N° 21.535, y está sujeto al control preventivo del Tribunal Constitucional (artículo 93 N° 1°).

Informe financiero. Deberá acompañarse el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, que estime el número de pensionados por invalidez en acto del servicio y el costo anual de sus tratamientos. El acotamiento del beneficio a los accidentes en acto del servicio, con exclusión de las enfermedades profesionales, está diseñado precisamente para que ese costo sea acotado y previsible.

Estrategia recomendada. Se sugiere: (i) elevar esta propuesta mediante oficio a S.E. el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, solicitando su patrocinio mediante Mensaje o su incorporación como indicación a una iniciativa en tramitación relativa a Carabineros de Chile; (ii) gestionar en paralelo el respaldo de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Defensa de ambas Cámaras; y (iii) solicitar a Carabineros de Chile y a DIPRECA los antecedentes estadísticos necesarios para el informe financiero.

General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

Abogado, Cientista Político

Magíster en Ciencia Política (mención Gobierno), Universidad de Chile

Miembro de Número de CENEOP - Past-President Cuerpo de Generales